

EAEU Regulatory Assistant

Поддержка регуляторного анализа
лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС

Режим работы

- ☒ Чат
- ☐ Регуляторная оценка
- ☐ База знаний

Модель и поиск

LLM: openai: gpt-4o

Эмбеддинги:

intfloat/multilingual-e5-base

Поиск: гибридный (вектор 40 + BM25
40 → RRF → 12)

Реранкинг: лексический (по
умолчанию)

Статус базы знаний

Документов	Чанков
755	11058
Векторов	Актов ЕАЭС
11058	747

EAEU Regulatory Assistant

Интеллектуальный ассистент регуляторной поддержки:
планирование регистрации лекарственных препаратов в
рамках Евразийского экономического союза

Чат с ассистентом

Задайте вопрос по нормативным требованиям ЕАЭС.
Ответ формируется только на основании найденных
фрагментов официальных документов.

Примеры запросов



Что требуется для регистрации
воспроизведённого лекарственного
препарата?



Для регистрации воспроизведённого
лекарственного препарата требуется
представить регистрационное досье,
которое должно включать резюме
обоснований и фактов, показывающих,
что препарат является
воспроизведённым, а также данные о его
качественном составе, количественном
содержании активного вещества и
профиле безопасности [9].
Биоэквивалентность воспроизведённого
препарата оригинальному должна быть
продемонстрирована соответствующими
исследованиями биодоступности [11].

Общая характеристика и инструкция по медицинскому применению воспроизведённого препарата должны соответствовать аналогичным документам оригинального препарата [11].

Периодический обновляемый отчет по безопасности на воспроизведённые препараты не подлежит представлению, за исключением случаев, когда это обязательство установлено при регистрации или на основании данных системы фармаконадзора [5]. Также, при регистрации воспроизведённого препарата заявитель может проводить пользовательское тестирование листка-вкладыша, однако это не является обязательным требованием [2].

В случае, если в ОХЛП и ЛВ оригинального препарата вносятся изменения, держатель регистрационного удостоверения воспроизведённого препарата должен внести соответствующие изменения в течение 120 рабочих дней [7].

Уверенность:
HIGH · 0.95

обоснован 4 нормативными
фрагментами

› Как получен этот ответ

Источники (4)

обязательных актов ЕАЭС: 4. Нажмите на источник, чтобы увидеть точный фрагмент.

 [5] Решение Совета ЕЭК № 81 от 19.05.2022 · Приложение № 9 · Часть III · Раздел 20 · Приложения к

- › периодическому обновляемому отчету по безопасности · п. 698–699 · с. 383–384

 [7] Решение Совета ЕЭК № 18 от 21.02.2025 · Приложение б/н · Раздел II · Представление информации о лекарственном препарате, а также вопросы,

- › касающиеся составления (изменения), экспертизы и одобрения информации о лекарственном препарате · п. 17, подп. б · с. 10–13

 [9] Решение Совета ЕЭК № 78 от 03.11.2016 · Приложение № 1 · Раздел II · Специальные требования

- › к модулям регистрационного досье лекарственного препарата · п. 6.1 · с. 159

 [11] Решение Совета ЕЭК № 78 от 03.11.2016 · Приложение № 1 · Раздел II · Специальные требования

- › к модулям регистрационного досье лекарственного препарата · с. 158–159



Хочу зарегистрировать пероральный нимесулид 200мг что мне нужно для

этого у меня джейнерик получается



Разработка и регистрация лекарственного препарата с МНН "нимесулид" в форме таблеток с модифицированным высвобождением, 200 мг, считается нерациональной в рамках Евразийского экономического союза. Это связано с отсутствием регистрации подобных препаратов в странах с высоким уровнем зрелости регуляторной системы и повышенными рисками нежелательных эффектов [1].

Для исследования биоэквивалентности воспроизведённого препарата с нимесулидом в форме таблеток рекомендуется использовать оригинальный препарат "Аулин" (Месулид) в качестве референтного [2]. Исследование должно проводиться с использованием однократного приёма, в два периода, с перекрёстным дизайном, натошак, с участием здоровых мужчин и небеременных, нелактирующих женщин [4].

Необходимо обеспечить, чтобы доверительный интервал для среднегеометрических отношений C_{max} и $AUC_{0-\infty}$ находился в пределах 80,00–125,00% [4].



Чтобы дать вывод по конкретному препарату, уточните:

- Укажите тип препарата (оригинальный, воспроизведённый, гибридный, биологический, биоаналоговый, комбинированный).
- Укажите лекарственную форму.
- Укажите характер высвобождения (немедленное / модифицированное).

Уверенность:
MEDIUM · 0.60

обоснован 3
нормативными
фрагментами

› Как получен этот ответ

Источники (3)

рекомендаций Экспертного комитета: 3.
Нажмите на источник, чтобы увидеть
точный фрагмент.

● [1] 429. Об оценке
рациональности разработки
› лекарственных препаратов с МНН
«нимесулид» в лекарственной
форме таблетки с мод · с. 1

● [2] О выборе референтного
лекарственного препарата для
целей исследования
› биоэквивалентности
лекарственных препаратов (содер ·
с. 1

● [4] О программе и дизайне
исследований биоэквивалентности

› лекарственного препарата,
содержащего действующее
вещество с МНН « · с. 1–2



а есть информация по препарату
elagolix



Достаточное нормативное основание в доступной базе знаний не найдено. В предоставленных фрагментах отсутствует информация, касающаяся специфических требований к регистрации лекарственного препарата с активным веществом элаголикс. Рекомендуется обратиться к актуальным решениям Совета ЕЭК и руководствам по регистрации лекарственных препаратов в ЕАЭС для получения более детальной информации.

Уверенность:
LOW · 0.00

ссылок на нормативные
фрагменты нет

› Как получен этот ответ

Найденные фрагменты (5)

обязательных актов ЕАЭС: 5. Ответ не опирается ни на один из них — это то, что вернул поиск.



[1] Решение Совета ЕЭК № 81 от 19.05.2022 · Приложение б/н · Часть I · «Обзорная информация по
› лекарственному препарату» модуль 2.3 «Общее резюме по качеству»; · с. 152

● [2] Решение Совета ЕЭК № 81 от 19.05.2022 · Приложение б/н · Часть I · «Обзорная информация по лекарственному препарату» · с. 155–156

● [3] Решение Совета ЕЭК № 87 от 03.11.2016 · Приложение б/н · Часть VII · – приложения. Если ПУР составляется на несколько лекарственных препаратов, для каждого из лекарственных препаратов должна быть предусмотрена отдельная часть. · с. 110–111

● [4] Решение Совета ЕЭК № 81 от 19.05.2022 · Приложение № 9 · Часть III · Раздел 17 · Оценка пользы · с. 369

● [5] Решение Совета ЕЭК № 81 от 19.05.2022 · Приложение № 9 · Часть VII · ‡ + + * # + + · Модуль CI Модуль CII Модуль CIII Модуль CIV Модуль CV
> Модуль CVI Модуль CVII Модуль CVIII
Лекарственный препарат с хорошо изученным медицинским применением + · с. 206–207



а что мы делаем с
высоковариабельными препаратами по
стах



Для высоковариабельных лекарственных
препаратов допустимые границы для
Стах могут быть расширены до 69,84-
143,19%, если клинически обосновано, что
такое расширение незначимо для
клинической эффективности и
безопасности [4]. Для этого необходимо
провести исследование с повторным
(репликативным) перекрестным дизайном
и подтвердить, что
внутрииндивидуальная вариабельность
Стах референтного препарата превышает
30% [11]. Заявитель должен доказать, что
вычисленная вариабельность достоверна
и не обусловлена выбросами [4].
Возможность расширения интервала
должна быть заранее оговорена в
протоколе исследования [4].

Уверенность:
HIGH · 0.75

обоснован 2 нормативными
фрагментами

› Как получен этот ответ

Источники (2)

обязательных актов ЕАЭС: 2. Нажмите на
источник, чтобы увидеть точный
фрагмент.



[4] Решение Совета ЕЭК № 85 от
03.11.2016 · Раздел III · Требования к
› дизайну, проведению и оценке

исследований биоэквивалентности
· п. 106–107 · с. 52–53

 [11] Решение Совета ЕЭК № 85 от
03.11.2016 · Раздел III · Требования к
, дизайну, проведению и оценке
исследований биоэквивалентности
· п. 104–105 · с. 51–52



т.е если у меня препарат имеет
cv>сколько? я должен переходить на
4рех периодное исследование



Для высоковариабельных препаратов,
если коэффициент вариации (CV)
превышает 30%, может потребоваться
проведение исследования
биоэквивалентности с повторным
(репликативным) перекрестным
дизайном. Это необходимо для
обоснования расширения допустимых
границ для C_{max} до 69,84-143,19%, если
клинически обосновано, что такое
расширение незначимо для клинической
эффективности и безопасности [11].
Возможность расширения интервала
должна быть заранее оговорена в
протоколе исследования [11].

Таким образом, если у вашего препарата
коэффициент вариации C_{max} превышает
30%, вы должны рассмотреть возможность
проведения 4-периодного исследования с
повторным дизайном для подтверждения
биоэквивалентности. Это позволит учесть

высокую вариабельность и обосновать расширение границ для Стах, если это необходимо для клинической значимости.

Уверенность:
HIGH · 0.85

обоснован 1 нормативными
фрагментами

› Как получен этот ответ

Источники (1)

обязательных актов ЕАЭС: 1. Нажмите на источник, чтобы увидеть точный фрагмент.

● [11] Решение Коллегии ЕЭК № 75
› от 25.06.2024 · 201060017-2023 · п.
2.3.14.0 · с. 33–40



а расширение границ стах всегда в рамках 69-143 или есть другие правила?



Расширение границ для Стах до 69,84-143,19% возможно для высоковариабельных лекарственных препаратов, если внутрииндивидуальная вариабельность Стах превышает 30% и это клинически обосновано [11]. Для этого необходимо провести исследование с повторным (репликативным) перекрестным дизайном и подтвердить, что вариабельность Стах референтного препарата действительно превышает 30% [11]. Возможность расширения интервала должна быть заранее оговорена в протоколе исследования [11].

Стандартные границы

биоэквивалентности для Стах составляют 80,00-125,00% [8]. Однако для высоковариабельных препаратов, где клинически незначимо большее различие в Стах, допускается расширение границ до 69,84-143,19% [11]. Это расширение не распространяется на AUC, границы которой остаются в пределах 80,00-125,00% независимо от вариабельности [8].

Уверенность:
HIGH · 0.75

обоснован 2 нормативными
фрагментами

✓ Как получен этот ответ

Разбор утверждений по типам

- **Нормативное требование:**
Стандартные границы биоэквивалентности для Стах составляют 80,00-125,00%. [8]
- **Нормативное требование:** Для высоковариабельных препаратов допускается расширение границ Стах до 69,84-143,19%, если внутрииндивидуальная вариабельность превышает 30% и это клинически обосновано. [11]
- **Нормативное требование:**
Расширение границ для Стах требует проведения исследования с повторным (репликативным) перекрестным дизайном. [11]
- **Нормативное требование:**
Возможность расширения

интервала должна быть заранее оговорена в протоколе исследования. [11]

- **Нормативное требование:**

Расширение границ биоэквивалентности не распространяется на AUC, границы которой остаются в пределах 80,00-125,00%. [8]

Уровень уверенности

Оценка вычисляется программно по признакам поиска и источников, а не запрашивается у языковой модели.

- Найдено источников: 2 (+0.20).
- Есть обязательные акты ЕАЭС (TIER 1–2): 2 (+0.25).
- Доля утверждений со ссылками: 100% (+0.20).
- Релевантность лучшего фрагмента (нормированная): 1.00 (+0.10).
- Ни для одного источника действующая редакция не подтверждена автоматически — требуется экспертная проверка.
- Итоговая оценка: 0.75 → HIGH.

Ограничения анализа

- Для 10 из 12 источников действующая редакция не подтверждена автоматически (version_status = requires_expert_validation). Перед

использованием вывода сверьте редакцию по официальному источнику.

Поиск

Реранкер: lexical-overlap · LLM: openai/gpt-4o

- запрос: а расширение границ стях всегда в рамках 69-143 или есть другие правила?
- фрагмент [1]: score=0.6186, методы: vector, bm25, rerank
- фрагмент [2]: score=0.5521, методы: vector, bm25, rerank
- фрагмент [3]: score=0.5464, методы: vector, bm25, rerank
- фрагмент [4]: score=0.5409, методы: vector, bm25, rerank
- фрагмент [5]: score=0.5303, методы: bm25, rerank
- фрагмент [6]: score=0.5253, методы: bm25, rerank
- фрагмент [7]: score=0.4800, методы: vector, bm25, rerank
- фрагмент [8]: score=0.4742, методы: vector, bm25, rerank
- фрагмент [9]: score=0.3882, методы: vector, rerank
- фрагмент [10]: score=0.3855, методы: vector, rerank

- фрагмент [11]: score=0.3829,
методы: vector, rerank
- фрагмент [12]: score=0.3028,
методы: vector, rerank

Источники (2)

обязательных актов ЕАЭС: 2. Нажмите на источник, чтобы увидеть точный фрагмент.

 [8] Решение Совета ЕЭК № 85 от 03.11.2016 · Раздел III · Требования к
› дизайну, проведению и оценке исследований биоэквивалентности
· п. 108–110 · с. 53

 [11] Решение Совета ЕЭК № 85 от 03.11.2016 · Раздел III · Требования к
› дизайну, проведению и оценке исследований биоэквивалентности
· п. 106–107 · с. 52–53



у меня препарат адреналин
внутривенный как мне его
регистрировать?



Достаточное нормативное основание для регистрации внутривенного адреналина в доступной базе знаний не найдено. Для регистрации лекарственного препарата в рамках ЕАЭС обычно требуется подача заявки с указанием международного непатентованного наименования (МНН), фармакотерапевтической группы,

лекарственной формы и дозировки [7].
Также могут быть применимы требования по безопасности, такие как предельные значения содержания эндотоксинов для внутривенных препаратов [5].

Рекомендуется обратиться к актуальным решениям Совета и Коллегии ЕЭК, а также к национальным регуляторным органам для получения полной информации о требованиях к регистрации адреналина в ЕАЭС.

Уверенность:
HIGH · 0.88

обоснован 2 нормативными
фрагментами

› Как получен этот ответ

Источники (2)

обязательных актов ЕАЭС: 2. Нажмите на источник, чтобы увидеть точный фрагмент.

● [5] Решение Коллегии ЕЭК № 75
› от 25.06.2024 · 55 201060021-2023 · п.
2.4 · с. 59–60

● [7] Решение Совета ЕЭК № 78 от
03.11.2016 · Приложение № 11 ·
Раздел I · Административная
› информация Идентификационный
номер заявки на регистрацию: · с.
444



а вообще внутривенные препараты как
регистрировать ты знаешь?



Для регистрации внутривенного препарата, такого как адреналин, в рамках ЕАЭС необходимо подготовить регистрационное досье, которое включает макеты упаковок и проект листка-вкладыша [3]. Также требуется представить отчеты о клинических исследованиях, если они проводились, и информацию о пострегистрационном опыте применения, если препарат уже зарегистрирован в других странах [6].

Процедура регистрации может осуществляться по процедуре взаимного признания или децентрализованной процедуре, в зависимости от выбора заявителя [11]. Важно также учитывать, что для внутривенных препаратов могут быть специфические требования, такие как предельные значения содержания эндотоксинов [5].

Рекомендуется обратиться к актуальным решениям Совета и Коллегии ЕЭК, а также к национальным регуляторным органам для получения полной информации о требованиях к регистрации внутривенных препаратов в ЕАЭС.

Уверенность:
HIGH · 0.95

обоснован 4 нормативными
фрагментами

› Как получен этот ответ

Источники (4)

обязательных актов ЕАЭС: 4. Нажмите на источник, чтобы увидеть точный фрагмент.

● [3] Решение Совета ЕЭК № 88 от
> 03.11.2016 · Приложение № 12 · п.
4.13–4.15 · с. 196–197

● [5] Решение Совета ЕЭК № 78 от
03.11.2016 · Приложение № 1 ·
Раздел I · Общие требования к
модулям регистрационного досье,
> сопровождающим заявление на
регистрацию лекарственного
препарата · п. 1.7.3–1.8.2.1 · с. 106–
107

● [6] Решение Совета ЕЭК № 78 от
03.11.2016 · Приложение № 1 ·
Раздел I · 3.2.S.4. · Общие
требования к модулям
> регистрационного досье,
сопровождаящим заявление на
регистрацию лекарственного
препарата · п. 5.3.5.2–5.3.7 · с. 157

● [11] Решение Совета ЕЭК № 78 от
03.11.2016 · Раздел III · Общие
> принципы регистрации
лекарственных препаратов · с. 20–
21

III. Общие принципы регистрации
лекарственных препаратов
20. Регистрация лекарственных
препаратов может осуществляться по
требованию заявителя
последовательно в нескольких
государствах-членах в соответствии с
процедурой взаимного признания
или одновременно в нескольких

государствах-членах в соответствии с децентрализованной процедурой регистрации.

21. Процедура взаимного признания осуществляется:

а) референтным государством в соответствии с настоящими Правилами с целью обращения лекарственного препарата на рынке только этого государства (национальная процедура регистрации);

б) в государствах признания – по желанию заявителя после регистрации лекарственного препарата в референтном государстве по процедуре взаимного признания.

22. Децентрализованная процедура регистрации осуществляется одновременно несколькими государствами-членами, в которые подано заявление о регистрации лекарственного препарата, с выбором референтного государства.

23. Заявитель самостоятельно осуществляет выбор референтного государства и при необходимости государства признания при подаче заявления на регистрацию лекарственного препарата.

24. Только одно государство может выступать в качестве референтного государства.

25. Требования к документам и данным регистрационного досье в формате общего технического документа, представляемого на регистрацию лекарственного препарата, установлены приложениями № 1 – 5 к нас...

Обязательный акт ЕАЭС · действует с изменениями · № 78 · от 03.11.2016 · с. 20–21 · загружен 11.08.2026

Редакция: первоначальная редакция;
известны акты о внесении изменений

[Исходный файл](#) · [Страница на сайте ЕАЭС](#)



при в/в введении можно
биоэквивалентность провести?



Требуется проведение исследования биоэквивалентности *in vivo* для внутривенных препаратов, если они не соответствуют условиям для биовейвера. Биоэквивалентность определяется как отсутствие значимых различий по скорости и степени, с которыми действующее вещество становится доступным в месте своего действия при введении в одинаковой молярной дозе в схожих условиях [1].

Для внутривенных препаратов, таких как адреналин, необходимо учитывать, что биоэквивалентность может быть подтверждена, если отсутствуют значимые различия в степени доступности действующего вещества [1]. В случае, если препарат имеет модифицированное высвобождение, необходимо провести статистическую оценку фармакокинетических параметров, таких как AUC и C_{max} [2].

Если препарат является раствором для внутривенного введения и содержит ту же концентрацию действующего вещества, что и референтный препарат, то

проведение исследований
биоэквивалентности может не
требоваться, если вспомогательные
вещества не влияют на
фармакокинетические параметры [7].

Уверенность:
HIGH · 0.88

обоснован 3 нормативными
фрагментами

› Как получен этот ответ

Источники (3)

обязательных актов ЕАЭС: 3. Нажмите на
источник, чтобы увидеть точный
фрагмент.



[1] Решение Совета ЕЭК № 85 от
› 03.11.2016 · Раздел II · Определения
· п. 11 · с. 7–13



[2] Решение Совета ЕЭК № 67 от
04.09.2020 · Приложение № 5 ·
› Раздел II · АУС(60.«); · Определения ·
п. 118 · с. 133–134



[7] Решение Совета ЕЭК № 85 от
› 03.11.2016 · Приложение № 1 · с. 60–
64

Ваш вопрос по регуляторным требованиям

